

Indicado pela Endocrinologia

ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS 22231696965 | 317

THAIS COSSERMELLI MAY

IDADE: 43 | PESO: 95 | ALTURA: 1,73 | PROFISSÃO: ADM.

SINTOMAS: Roncos pronunciados, cansaço noturno diurno, Enxaqueca

QUEIXAS:

MEDICAMENTOS: Duramtu / hidroclorotiazida / Propanolol

MÉDICO: Dra. Roberta Vannuchi (Endocrinologia)

MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N

EXERCÍCIO FÍSICO: 2x semana (aeróbica / dança)

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 5 | ALMOÇO: 5 | LANCHE: 5 | JANTAR: 19h

HORA QUE DORME: 23h | HORA QUE ACORDA: 7:30 - 8h

COCHILHO () S (X) N | DORME ACOMPANHADO: (X) S () N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: (X) S () N / DORMEM NO QUARTO: (X) S () N | PET NO QUARTO: (X) S () N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA (X) N

FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal

BANHEIRO/NOITE: não

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não

MALLAMPATI: IV

IAH: 22,6 e/h | SPO2: 87%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: HAS | tireoide

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA

(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N | SPO2 C/ CPAP: | PRESSÃO NO EXAME:

05/11/24 Avaliação Auto 4-10 cmH₂O Max dream wear (S)12/11/24 P = 6.3 cmH₂O (med) fixo: 6,4 cmH₂O

IAH = 1.4 e/h

m de uso: 6h53'

fuga: 7.2 e/h/m

Bem adaptada

Natacha

26/11 P = 6.4 cmH₂O

IAH = 1.3 e/h

m de uso: 6h47'

fuga: 0.9 e/h/m

Bem adaptada

S/ queixas

Natacha

10/03 P = 6.4 cmH₂O

IAH = 1.2 e/h

m. de uso: 6h45'

Relata melhora do sono.

Ana

20/01/25 $P = 6,4 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 1,7 \text{ e/h}$
m de ura: 6h 24'
fuga: 2,9 l/min

Bem adaptada
s/ queixas
Natasha

03/02/25 $P = 6,4 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 1,5 \text{ e/h}$
muro = 7h 10 min.
fuga = 9 l/min.

Bem adaptada

(não usa cartão crédito
queria PIX a vista em 2x → não liberado
pela Ana)

Silvia

09/06/2025 $P = 6,4 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 1,4 \text{ e/h}$
muro = 7h 08 min
fuga = 6 l/min.

Bem adaptada

Silvia

Nome: THAIS COSSERMFI 11 MAY
Data de Nascimento: 8-7-1981
IMC: 31,74
Sexo: Feminino
Data do exame: 23-08-2024

Peso: 95 kg
Altura: 1,73 m
Médico: DRA. ROBERTA ROMEIRO
VANNUCHI
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 23-08-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 484,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 65,5 e 217,5 minutos. O tempo total de sono foi de 311,0 min, eficiência de 64,2% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,9%; estágio N2: 60,3%; estágio N3: 17,5%; sono REM: 20,3%. O índice de despertares foi de 9,3/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 22,6/hora, sendo 0 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 117 hipopnéias. A SpO2 média foi de 93% e a mínima de 87%, permanecendo 0,9% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 53 - 83 bpm e NREM de 51 - 85 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (14), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 22,6/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=87%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. número de despertares breves normal;
7. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau moderado.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157